外科学 骨科疾病

核心精讲·手外伤、股骨头坏死、膝关节损伤、神经损伤

（性感认识：理解是为了记住它）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、手外伤

（1）清创后一期（6-8 小时内）修复血管、神经、肌腱、骨组织。若超过 12 小时，除了血管应立即修复以外，其它可考虑延期（3 周）、二期（12 周）修复

细菌呈指数繁殖

（2）方式

皮肤裂伤（没有缺损）	直接缝合
皮肤缺损	皮片移植
神经、肌腱、骨关节外露	皮瓣（含有皮下脂肪的皮肤）移植

（3）固定在功能位（握球状）规律:固定在功能位,但不同部位的功能位不同



图 62-1　手的休息位



图 62-2　手的功能位

（4）断肢/指再植

①成功率（断面是否整齐）：切割伤＞碾压伤＞撕脱伤

②**6-8 小时内**，断指可延长至 12-24 小时

③无药敷料密封**干燥**冷藏

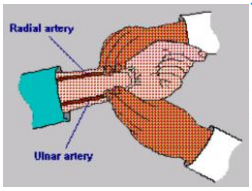


图 62-8　断手的保存法



（5）Allen 试验(+)：侧枝循环不良→禁止桡动脉穿刺

判断桡动脉-尺动脉的侧支是否沟通



松开尺动脉手掌变红说明桡尺之间是沟通的,若手掌仍是白的则说明桡尺不沟通

二、股骨头无菌性坏死（缺血造成骨梗死）

1.病因

①外伤损伤旋股内侧动脉的分支髓外侧动脉，如**股骨颈骨折、髋关节脱位** 一般为单侧

②**糖皮质激素、乙醇、减压/沉箱/潜水员病（氮气栓塞）、镰状细胞贫血或地贫**，多为双侧（GC 地易建联）

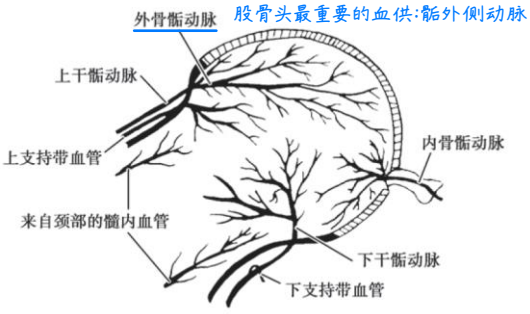


图 68-1　股骨头、颈的血供

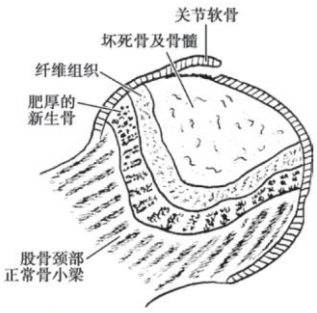


图 68-2　坏死股骨头的冠状面